

1/ Rappel des recommandations de l'OMS (adultes)

- AP aérobie d'intensité modérée 2h30-5h/sem (≥30 min, ≥5j) ou d'intensité intense 1h15-2h30/sem ou combinaison des 2.
- Renforcement musculaire des principaux groupes ≥2 fois/sem
- limiter temps de sédentarité → AP même faible intensité + Travail équilibre ≥3 x/sem si PA ≥65 ans, si maladie chronique

Tableau 1 : Classement Activité Physique (AP) selon intensité

AP	Sédent.	Faible	Modérée	Intense	Très intense
MET	≤1,5	1,6-3	3-6	6-9	>9
Borg	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10
Repère	0	FC perçue	Essoufflement, conversation possible	Conversation difficile (3 mots)	Conversation impossible
Type AP*	Assis : TV, lire, déplac moto. ...	Marche<4 km/h, s'habiller, promener chien, Act. debout	Marche 5-6.5 km/h, montée lente escaliers, CAP<8 km/h, vélo et nage loisir, jardinage	Marche >6.5 km/h, montée rapide escalier, CAP 8-9 km/h, vélo 20-25 km/h	CAP > 9 km/h, vélo > 25 km/h

* Pour des adultes d'âge moyen et de condition physique moyenne (guide HAS)

2/ Besoin avis médical minimal avant augmentation AP ?

- AP faible tjs possible sans avis médical (mieux que sédentarité)
- Informations nécessaires : niveau souhaité d'AP (modéré, intense, très intense) ET âge ET Q-AAP+ : signes d'alerte (QS), ATCD de maladie chronique, traitement en cours (evt).

Tableau 2 : indication avis médical en pop générale (HAS)

Âge	Signes d'alerte Maladie chronique Traitement (Q-AAP+)	Niveau visé AP Compendium AP &... HAS p60-61	Besoin Avis Médical CmAP
<45 ans	NON (Q-APP+=0)	Modéré	NON
	OUI (Q-APP+≥1)	Modéré	OUI
		Intense	OUI
>45 ans	NON (Q-APP+=0)	Modéré	NON
		Intense	OUI
	OUI (Q-APP+≥1)	Modéré	OUI
		Intense	OUI

En résumé, pas d'avis médical si pas de signe de maladie chronique (dt CV) ni de pb ostéoarticulaires (<12 mois), si traitement =0, symptômes notamment à l'effort =0 (Q-APP+=0) chez <45 ans et intensité AP visée + chez >45 ans si AP visée = mod (avis médical si Q-AAP+0 ou >45 ans + AP intense).

→ Situation 1 : Pas d'avis médical, conseils de pratique (tab 5)

→ Situation 2 : Avis médical (CmAP) : voir page suivante.

3/ Consultation minimale médicale

• Informations à recueillir

- ATCD/Tabac/Symptômes/traitement(s)
- Examen Physique dt PAS
- AP actuel : actif/inactif, sédentaire → GPAQ ou Marshall
- AP visée : faible, mod, (très) intense
- RCV (tab 3) : faible/ modéré/ (très) élevé
- Risque Blessures MS & Cut. ? (Tableau 7)
- Cl et limitations ? (Tableaux 8, 9)
- Biologie : utile pour SCORE2 (biologie avec GAI, bilan lipidique, créatinine Compendium AP ou HAS tab p60 pouvant se justifier si non faite depuis 1 an)

• Motivation : évaluation motivationnelle rapide (Prochaska)

Pratiquez-vous une AP régulière ?

- OUI (actif) : La pratiquez-vous depuis 6 mois ?
 - Oui (stade consolidation) : encourager, féliciter (continuez !)
 - Non (stade action) : idem +/- diversifier les activités, prévenir et anticiper les rechutes
- NON (inactif) : Envisagez-vous de vous engager dans une AP régulière dans les 30 prochains jours ?
 - Oui (stade préparation) : Renforcement positif de la pratique, aide à fixation objectifs, proposer un plan précis et simple
 - Non : Avez-vous l'intention de vous engager dans une AP régulière dans les 6 mois ?
- Oui (stade intention) : Communiquer sur les avantages/inconvénients AP, faire verbaliser
- Non (stade indétermination) : Transmettre qq infos, dire qu'on est dispo, proposer plus tard

Aide à l'EM

Tableau 3 : Risque Cardio-Vasculaire (Guide HAS AP 2022, p29)

Faible	SCORE2 ou SCORE2-op faible →	
Modéré	SCORE2 ou SCORE2-op modéré →	
Élevé et très élevé	SCORE2 ou SCORE2-op élevé →	
Maladie CV documentée (SC et/ou imagerie) : coronaires, maladies vasculaires périphériques (AOMI, revascularisation artérielle) et cérébro-vasculaires (AVC, AIT)		
Diabètes de type 1 ou 2 (sauf individus jeunes avec diabète de type 1 et sans autres FDR CV majeurs pouvant être considérés comme à risque modéré ou faible)		
IRC modérée (DFG 30-59 ml/min) - sévère (DFG <30 ml/min)		
Facteur majeur de RCV nettement augmenté, en particulier : CT > 3,1 g/L (8 mmol/L) ou HTA ≥ 18/11		

NB1 : le guide HAS choisit d'être plus sécuritaire pour l'évaluation du RCV : le SCORE2 diabète peut être modéré alors que le tableau indique un risque élevé/très élevé pour un diabétique 2.

NB 2 : pour le calcul du risque cardiovasculaire, je conseille le site [risqueCV.fr](#) du Dr Nathan Collange, qui s'adapte à toutes les situations du patient.e.

• Conduite à Tenir

○ Si symptômes : PEC classique, si Cl/Lim. AP (tab 7-9) : CMAP

○ PAS de Σ ni CI AP : Situations particulières -> Situation 3

- Handicap : CMAP préco ± avis méd spécialisé ± médicotech.
- Maladie respiratoire chronique (BPCO, asthme, PID) : CMAP (+ avis pneumo) peut être préconisée selon gravité patho. r.
- Cancer : CMAP préconisée
- Obésité ET IMC≥35 ET AP intense visée : evt CMAP*
- Grossesse ET complication obsté. ou comorbidité : CMAP reco
- ATCD CV* ET AP intense visée : ECG repos et/ou avis cardio
 - *Personnel de maladie CV hors HTA équilibrée
 - *Familial de MCV héréditaire ou mort subite <50 ans chez membre de fratrie au 1^{er} degré ET Âge ≤ 35 ans
- ATCD CV familial (qq's âge) ET AP intense : EE indiquée

○ Pas de situations particulières : voir tableau 4 (CMAP ?)

• Situation 4 : CMAP (adresser patient.e pour CMAP)

• Situation 5 : CMAP non indiquée-> tableau 5 (ordo, conseils)

Tableau 4 : indication CMAP ± EE selon RCV et AP visée

Statut actuel AP	Niveau visé AP	RCV	Indication CMAP	Indication Épreuve d'Effort (EE)
Inactif/actif	Faible, modéré, intense	Faible, modéré, élevé & très élevé		
Marshall GPAQ	Compendium AP ou tableau HAS	Tableau 3	OUI/NON	OUI/NON
Inactif	Modéré	Faible	-	NON reco
		Modéré	-	NON préco
		Élevé/très élevé (ou âge ≥70 ans ou notion anti cancéreux cardiotoxique =tt K CardioTox)	Selon le contexte* (non systématique)	NON préco
	Intense	Faible	-	NON préco
		Modéré	OUI (préconisée)	Evt réalisée
		Élevé/très élevé (ou >65 ans ou tt K CardioTox)	OUI (préconisée)	OUI (reco)
Actif	Modéré	Faible	-	NON reco
		Modéré	-	NON préco
		Élevé/très élevé	-	NON préco
	Intense	Faible	-	NON reco
		Modéré	OUI (préconisée)	NON préco
		Élevé/très élevé (ou >65 ans ou tt K CardioTox)	OUI (préconisée)	OUI (reco)

* « non systématique mais si elle se justifie en cas de contexte particulier » (HAS).

En résumé : AP modérée : PAS d'avis médical sauf si RCV (très) élevé chez inactif (CMAP +/- EE, peut être proposée, car ↑ niv AP). Si AP intense visée + RCV ≠faible = CMAP, si AP intense + RCV élevé/très élevé = EE (CMAP+EE).

• CONCLUSION de la Consultation minimale d'AP (CmAP)

○ Déterminer le cadre de la pratique

- Niveau 1 : protocole de rééducation avec MK, (hors Guide HAS)
- Niveau 2 : APA si maladie et/ou état fonctionnel justifiant d'un programme d'APA si maladies chroniques, ou facteurs de risques et personnes en perte d'autonomie (individuel, groupe), evt [Maison Sport Santé](#)
- Niveau 3 : Sport Santé avec éducateur spécialisé (individuel, groupe)
- Niveau 4 : en autonomie si patient capable d'augmenter son AP seul (ressources psychiques/physiques) : [catalogue d'AP du site Manger Bouger](#)

○ Rédiger l'ordonnance d'AP ± Certif de non CI (ordo = ↑ observance)

Préambule : choisir avec patient les objectifs souhaités/atteignables

- FITT (fréquence, Intensité, Temps, Type : aérobie, RM, équilibre ...)
 - ± Précautions de pratique et CAT en cas de situations d'urgence
 - Si APA : limitations éventuelles (physiques, psychiques, mentales)
 - Aides éventuelles pour financement : Mairie, [Mutuelles \(voir tab 6\)](#)
- NB : Noter l'autorisation patient sur ordo si éléments médicaux (SM)

○ Éducation/information de la personne : Tableau 5

- Conseils contre sédentarité : ↓ tps assis <7h, lever 1'/h, transport actif
- Pour augmenter son niveau d'AP
 - Informer sur AP : intensité & durée décidées, reco OMS (tab 1) et bienfaits AP, type d'AP (aérobie, RM, souplesse ± équilibre)
 - Progressivité : surtout si sédentaire inactif, débiter par AP faible puis augmenter progressivt, vigilance sur signes d'alerte
 - Signes d'alerte : douleur thoracique (± irradiation angineuse), essoufflement ou fatigue inhabituels, syncope, vertiges, palpitations, tachycardie, FC irrégulière, OMI, claudication intermittente : si +, arrêt AP et consultation rapide.
- A chaque séance d'AP : [10 règles d'or Club des cardiologues du sport](#)
 - AVANT : Se renseigner et adapter l'AP selon les conditions : température ext. (⚠ si >30, <-5), pollution, pas AP intense si fièvre & dans les 8j d'un Sd grippal, pas tabac 2h avant & après, ni dopant +/- précautions selon pathologies/handicaps QS
 - PENDANT : Début par échauffement (5-10'), s'hydrater (3-4 gorgées d'eau/30'), à la fin, retour au calme progressif (5-10'), si présence de signes d'alerte pendant ou juste après l'effort : arrêt AP et avis médical.
 - APRES : vérifier l'absence signes d'alerte, pas de tabac pt 2h.
- Evt proposer un carnet de suivi (voir QR codes dans le mode d'emploi, p3)

○ Programmer le suivi : fixer prochain rdv.

💡 Voir [Tableau 6](#) : RESSOURCES (exemple d'ordo, fiches patient ...)

4/ Consultation Médicale d'activité physique (CMAP)

Pour information : dure ≥30 min, plus complète /CmAP : évaluation clinique et motivationnelle complète, évaluation de la condition physique (IMC, Périmètre abdo, capacités cardiorespiratoires ([test de marche de 6 min](#), stepper 6 min, levers de chaise), aptitudes musculaires (MI : lever de chaise/min ou en 15 sec, MS : curl-up test n/min, Abdo, handgrip).

IMPORTANT : Ce guide vise à vous aider à prescrire de l'AP. Il se base sur le [guide HAS « consultation et prescription d'AP à des fins de santé de l'adulte »](#) qui ne traite pas des patients relevant d'une rééducation, ni du sport en compétition. Il vise à déterminer quels patients doivent avoir une évaluation médicale minimale (CmAP, 15') et/ou complète (CMAP, ≥30').

Tableau 6 : RESSOURCES web Activité Physique (AP)

Exemples d'ordonnances 	Fiche motivation/conseils AP 
Fiche promotion AP 	Fiche Web AP PATIENT 
Fiches AP/pathologie HAS 	Fiche Auto EVALUATION AP 
Outil génération CRC 	Annuaire Maison SS 
Financement Mutuelle (AzurSS) 	Mode d'Emploi (+ liens/QRc) 

Dans le mode d'emploi, vous trouverez : outils pratiques, documents à consulter et télécharger (ex d'ordonnances, fiches patients etc.), lexique et ... un mode d'emploi.

Toute suggestion ou remarque est la bienvenue : antoine.bosquet@aphp.fr.

© Antoine Bosquet – Parcours Cardiovasculaire. Service de Médecine Interne, Hôpital Louis Mourier, AP-HP, Paris, v20260504 – 2026. Licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Attribution requise. Usage non commercial uniquement. Toute modification doit être partagée dans les mêmes conditions.

Tableau 7

Situations à risque de blessures musculosquelettiques et cutanées

- Patho osseuse ou articulaire, malformation (agénésie, scoliose, ...)
- Ostéopathie fragilisante et/ou avec des ATCD de chutes
- ATCD blessures graves à l'AP
- Personnes âgées fragiles ou à risque de chute
- Neuropathie MI avec risque de plaie cut. des pieds (diab, etc.)
- Certaines Personnes en situation de handicap
 - Physique
 - Amputation, troubles neuro-orthopédiques
 - Atteinte musculaire d'origine neuro, dégénérative ou traumatique (spasticité, rupture coiffe, etc.)
 - Lésion médullaire
 - Sensoriel, visuel, auditif ou tr équilibre plus à risque de chutes
 - Psychique + tr cognitifs, psychotiques, de l'humeur et/ou avec comportements à risque ou traités avec des psychotropes
- Personnes & dispositif médical/aide technique (fauteuil roulant, canne, prothèse, orthèse, stomie, etc.)

Tableau 8 : Contre-indications / limitations à l'activité physique (AP)

- Contre-indications absolues à l'AP
 - Insuffisance cardiaque décompensée
 - Troubles rythmiques ventriculaires complexes
 - Hypertension artérielle sévère non contrôlée
 - Hypertension artérielle pulmonaire (> 60 mmHg)
 - Myocardite ou épanchement péricardique aigu
 - Myocardiopathie obstructive sévère
 - Rétrécissement aortique serré et/ou symptomatique
- Contre-indications absolues et temporaires AP ≥Modérée
 - Toutes les pathologies aiguës
 - Toutes pathologies chroniques décompensées / non stabilisées
 - Dénutrition importante
 - Fatigue extrême et/ou incapacité physique manifeste à l'AP
 - Anémie marquée (Hb < 8 g/dL)
- Contre-indications relatives pour AP élevée
 - Insuffisance respiratoire chronique sous O2 de longue durée
 - Patho. respiratoire chronique sévère (risque désat. à l'effort)
 - Diabète avec rétinopathie sévère, traitement récent au laser chirurgical de l'œil ou dysautonomie sévère
 - Porteurs de drépanocytose

Tableau 9 : Contre-indications et limitations MS et Cut. à l'AP

- CI Absolues et temporaires pour les AP pour la zone concernée
 - Pathologies traumatiques non consolidées
 - Path ostéo-articulaires en poussée congestive (arthrose, arthrite)
- CI absolues/temporaires pour AP ≥modérée pour la zone concernée
 - Diabète + mal perforant plantaire pour AP avec 2 MI (même si unilat)
 - Escarre/plaie évolutive ou chronique selon gravité, localisation
- Risque contact, frottement physique ou liée à AP (piscine, sable, terre, etc)